DBT

MATERIAL DE APOIO · AULA 10 DE 12

Regulação emocional

Por que as emoções são centrais na DBT, a diferença entre o modelo de emoções universais e o de emoções construídas, e as habilidades práticas — ação oposta, PLEASE, resolução de problemas — para regular sem suprimir.

ENCONTRO DE SÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 2026
CONDUZIDO POR JÚLIO GONÇALVES, COM ANDRESSA JULIANA

DESCOMPLICANDO A DBT

Quem conduz a formação

Doze encontros ao vivo, aos sábados, para sair da leitura sobre DBT e chegar na condução da sessão — da teoria biossocial ao manejo de crise, com o pé na prática clínica.



IDEALIZADOR · PROFESSOR

Júlio Gonçalves



IDEALIZADORA · PROFESSORA

Andressa Juliana

Este material acompanha o encontro

As últimas páginas são preenchíveis: marque o checklist, responda as perguntas de revisão e guarde suas anotações no próprio arquivo. Salve depois de preencher.

O ESSENCIAL

— Emoções são produtos da evolução — um serviço de notícias automático que lê o ambiente e atualiza o corpo e o cérebro, não um antecedente isolado do comportamento.

— Nos extremos, autolesão, dissociação e tentativas de suicídio funcionam como estratégias do corpo para reduzir rapidamente um sofrimento emocional insuportável — entender essa função reduz a frustração e a culpa dirigidas ao paciente.

— Diante de risco grave à vida, a prioridade é tolerância ao mal-estar e estratégias biofisiológicas intensas — a regulação emocional de médio prazo entra depois, quando há fôlego psicológico.

— O modelo de emoções universais (Ekman) serve à psicoeducação, mas a prática clínica pede o modelo de emoções construídas (Feldman Barrett): a linguagem e a história de cada pessoa moldam como uma sensação corporal ambígua é nomeada.

— Por trás de emoções intensas e desreguladas, quase sempre existe um valor de vida que o paciente ainda não nomeou — o medo intenso de abandono, por exemplo, costuma mascarar o valor de ter um relacionamento seguro.

01 Por que trabalhar emoções é central na DBT

A maior parte dos pacientes busca terapia por demandas emocionais — mas é comum tratar a emoção como um sintoma isolado, quando na verdade ela é o nó que sustenta todo o funcionamento e o sofrimento do paciente. A DBT contempla essa centralidade através de três módulos que se cruzam: atenção plena, tolerância ao mal-estar e regulação emocional. Trabalhar diretamente com a emoção, e não ao redor dela, é o que permite interromper o ciclo de sofrimento.

02 Função evolutiva das emoções, dos extremos aos comportamentos de risco

Tratar emoções como meros antecedentes de comportamento é um erro comum. Emoções são produtos da evolução, presentes desde espécies simples até mamíferos complexos, e cumprem uma função de sobrevivência — não são um defeito a ser eliminado.

Nos casos extremos, comportamentos como autolesão, dissociação (entendida como uma simulação de morte) e tentativas de suicídio funcionam como estratégias do corpo e do cérebro para se proteger de ambientes aversivos e reduzir rapidamente o sofrimento emocional. A emoção, mesmo nesses extremos, cumpre uma função de leitura ambiental — e precisa ser identificada em sua raiz, não só no comportamento que ela produz.

03 Emoções como serviço de notícias: automaticidade e vulnerabilidade biológica

As emoções atuam como um serviço de notícias automático, captando minúcias do ambiente e atualizando o cérebro em tempo real — sem passar primeiro pelo crivo da razão. Julgar um paciente por falta de engajamento quando ele reage de forma automática ao ambiente é desconhecer esse mecanismo.

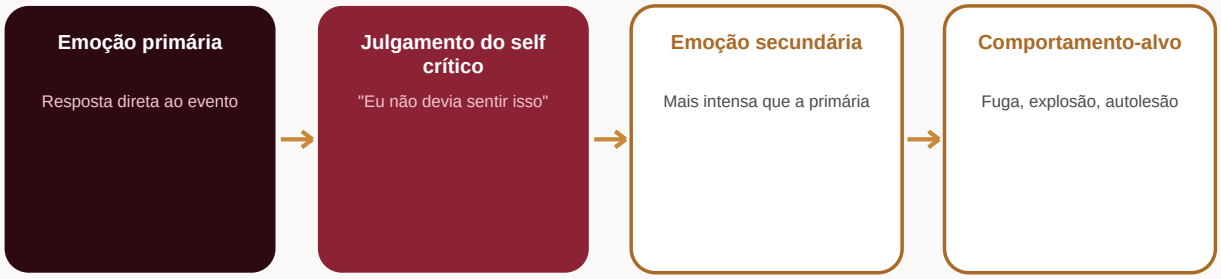
Variações sazonais, privação de sono e má alimentação criam vulnerabilidades biológicas que aumentam a sensibilidade a estímulos aversivos. Entender essa automaticidade ajuda o terapeuta a reduzir a própria frustração e a culpa dirigida ao paciente diante de reações que parecem desproporcionais.

04 Exercício: emoções primárias e secundárias

Um exercício prático: a pessoa acessa a memória de um erro recente e avalia os próprios sentimentos numa escala de zero a dez, ao longo de quarenta segundos. O que costuma aparecer é uma emoção secundária, mais complexa, construída em cima de um julgamento do self crítico — e, com frequência, mais intensa do que a emoção primária que a originou.

As pessoas participantes costumam se dividir em três padrões de resposta: quem não sente nada de imediato, quem foca na situação externa, e quem foca na própria emoção. O segundo padrão — focar na situação — tende a indicar um processo terapêutico mais avançado, por deslocar a explicação para o contexto em vez de para um defeito pessoal.

FIGURA 2 · DA EMOÇÃO PRIMÁRIA AO COMPORTAMENTO-ALVO



A emoção secundária costuma ser mais intensa que a primária — porque carrega um julgamento em cima dela.

05 Risco à vida primeiro: tolerância ao mal-estar antes da regulação emocional

Diante de risco grave à vida, a intervenção direta prioriza a tolerância ao mal-estar e estratégias biofisiológicas intensas — como gelo ou banho frio, já previstas no plano de segurança. Só conforme o paciente adquire fôlego psicológico é que a regulação emocional de médio prazo entra em cena, para lidar com situações cotidianas: checagem de fatos, ação oposta, o módulo PLEASE, surfar nas emoções e resolução de problemas, atuando em cada elo da cadeia comportamental.

06 O modelo de emoções universais de Paul Ekman — e seus limites

O modelo de Paul Ekman trata as emoções como entidades internas discretas — ansiedade, raiva, alegria — cada uma com um sinal fisiológico universal e reconhecível. É um modelo útil para a psicoeducação, por sua simplicidade, mas falha diante dos estudos fisiológicos atuais: a mesma emoção relatada por pessoas diferentes não corresponde a um padrão corporal único e constante (Ekman, 1992).

07 O modelo de emoções construídas de Lisa Feldman Barrett

Em contraponto, o modelo de emoções construídas de Lisa Feldman Barrett propõe que a linguagem e os conceitos que cada pessoa aprendeu ao longo da vida têm papel primordial em como uma sensação corporal ambígua é nomeada e sentida (Feldman Barrett, 2017). Na prática clínica, isso aparece de forma concreta: diante da mesma ficha de registro, cada paciente escolhe de um jeito diferente como sente — e o que comunica sobre — a mesma emoção.

08 Como o cérebro constrói o significado emocional

Se até um objeto concreto como "pinguim" produz uma variação grande de definições entre pessoas diferentes, palavras abstratas como vergonha, culpa ou ansiedade variam ainda mais, conforme a linguagem e a história de vida de cada pessoa.

> **O estudo do "pinguim"**
>
> O exemplo citado em aula corresponde a um estudo de Martí, Wu, Piantadosi e Kidd (2023), da Universidade da Califórnia em Berkeley: ao pedir que as pessoas descrevessem o próprio conceito mental de palavras simples como "pinguim", os pesquisadores encontraram pelo menos dez a trinta variantes distintas de conceito — com cerca de 12% de chance de duas pessoas escolhidas ao acaso compartilharem exatamente o mesmo conceito.

Um exercício visual com imagens progressivas — traços que aos poucos revelam um cavalo, depois um sapo — ilustrou como o cérebro preenche lacunas e constrói significado ativamente, antes mesmo de a imagem completa estar disponível. É a mesma lógica que opera na leitura de uma emoção: o cérebro antecipa um significado a partir de fragmentos, usando a experiência prévia como atalho.

09 Histórico de aprendizagem, ambientes validantes e invalidantes

O cérebro categoriza respostas fisiológicas ambíguas com base em experiências prévias — por isso a mesma sensação de alerta pode ser lida como medo diante de um cão e como afeto diante de um gato, dependendo do histórico de cada pessoa com esses animais.

Ambientes invalidantes — frequentemente associados ao desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline — moldam de forma mais rígida as crenças sobre si e sobre o ambiente, em contraste com ambientes validantes. A diferença não está só no conteúdo das crenças, mas na granularidade da experiência emocional que resulta desse histórico.

10 Granularidade emocional e o papel da rede de apoio

Granularidade é a quantidade e a qualidade das interações de validação ou invalidação vividas ao longo da vida — tipicamente baixa em pessoas com transtorno de personalidade borderline. A rede de apoio é fundamental para aumentar essa granularidade, e a própria pessoa que atende pode atuar como modelo de validação, ajudando a desenvolver o que se chama de metagranularidade: a capacidade de diferenciar e nomear estados emocionais cada vez mais específicos.

11 Valências, excitação e o mapa do afeto

A vida emocional se organiza em valências agradáveis e desagradáveis, cruzadas com níveis de excitação corporal — alta ou baixa. Valências agradáveis podem se tornar desagradáveis com relativa facilidade, por meio de uma experiência específica como um trauma ou acidente; o caminho inverso é muito mais difícil de percorrer sem um processo sistemático de exposição emocional, porque o cérebro está primordialmente voltado à proteção, não ao prazer.

Pessoas com transtorno borderline oscilam constantemente entre os quadrantes desse mapa. A meta principal do tratamento é reduzir o tempo passado no quadrante de alta excitação e valência desagradável — onde mora o risco grave à vida — e direcionar o atendimento para estados de menor risco.

FIGURA 1 · O MAPA DO AFETO



A meta do tratamento é reduzir o quadrante de alta excitação e valência desagradável — onde mora o risco grave à vida.

12 Por que reverter um pareamento aversivo é difícil

Um pareamento entre um estímulo e uma resposta aversiva, construído ao longo da vida, é difícil de desfazer — como no exemplo de um falso alarme de perigo gerado ao caminhar por uma trilha, mesmo sem ameaça real presente. Psicoeducação isolada, ou intervenções superficiais, não desfazem esse pareamento: ele exige um tratamento completo e estruturado ao longo do tempo, não uma explicação pontual sobre como a emoção funciona.

13 Rede de apoio e efetividade interpessoal

Fortalecer a rede de apoio por meio da efetividade interpessoal acelera a saída de estados emocionais aversivos: amplia a granularidade emocional e amplia também a capacidade da pessoa de selecionar, ativamente, ambientes mais validantes para si — em vez de permanecer em contextos que repetem a invalidação.

14 Vulnerabilidade biológica na tomada de decisão: o estudo dos juízes

Usando o estudo sobre juízes citado por Daniel Kahneman em "Rápido e Devagar", a aula ilustrou como a fome próxima ao horário do almoço torna decisões e sentenças mais rígidas — um exemplo claro de como a vulnerabilidade biológica, por si só, afeta o julgamento, independentemente da vontade ou do caráter de quem decide (Kahneman, 2011; Danziger, Levav & Avnaim-Pesso, 2011).

15 Escolhendo o contexto de exposição

A seleção do contexto inicial de exposição emocional precisa considerar o nível de aversividade do estímulo e a necessidade de uma sensibilização sistemática — começando pelo mais acessível, não pelo mais temido. A comparação entre reações a quedas de bombas em contextos muito diferentes ilustrou como o mesmo tipo de evento pode ter um peso emocional completamente distinto dependendo da história prévia de exposição da pessoa. O treino de habilidades de regulação começa em contextos mais acessíveis e menos aversivos, avançando de forma gradual.

16 Os valores por trás das emoções intensas

Por trás de emoções intensas e desreguladas, existem quase sempre valores fundamentais de vida que o próprio paciente desconhece ou não nomeou. Um medo intenso de abandono, por exemplo, costuma mascarar o valor de construir uma família ou um relacionamento seguro — e nomear esse valor, não apenas o medo, muda a direção do trabalho terapêutico.

17 Sistema de fichas Desc DBT e o treino de habilidades

Um sistema digital próprio, acessível pelo site "descomplicando" e protegido por senha, reúne fichas e formulários adaptados ao contexto brasileiro, com base na terapia comportamental dialética — material de apoio prático para o uso clínico das habilidades descritas nesta aula.

18 Reconhecer e discriminar emoções: o primeiro passo

A primeira habilidade a ser ensinada é o reconhecimento e a discriminação das emoções, já que os pacientes frequentemente não sabem identificar o que sentem no próprio corpo. Pequenas exposições experienciais em sessão ajudam a mapear fatos, pensamentos e a distinguir emoções primárias de secundárias — a mesma lógica do exercício descrito na seção 04, agora aplicada clinicamente.

A análise em cadeia, conduzida após semanas de monitoramento, tem como foco entender os elos entre vulnerabilidade biológica, emoções secundárias e o comportamento-alvo — promovendo regulação emocional antes que o comportamento ocorra, não só depois dele.

19 Vulnerabilidade física (o acrônimo PLEASE) e vulnerabilidade cognitiva

Para lidar com vulnerabilidades físicas que afetam o humor, a DBT usa o acrônimo PLEASE: tratar doenças físicas, cuidar da alimentação (evitando usar comida como anestesia emocional), cuidar do sono, praticar

exercício físico e evitar substâncias que alterem o humor (Linehan, 2015).

Antes de iniciar a reestruturação cognitiva por questionamento socrático e registro de evidências, o corpo precisa estar regulado — por isso práticas de mindfulness vêm primeiro. A realização consistente das tarefas de casa é o que sustenta o treino contínuo de todas essas habilidades.

20 Contínuo cognitivo adaptado e ativação comportamental

Um exercício adaptado do contínuo cognitivo clássico trabalha o autocriticismo, o self envergonhado e a ideia de que o mundo deveria ser perfeito — contextualizando a história de pessoas de referência para o paciente. A DBT, sendo transdiagnóstica, permite esse uso flexível de estratégias que vão além do manual principal.

A ativação comportamental se baseia em cruzar o tipo de contexto (agradável ou desagradável) com o nível de atividade (ativo ou inativo). A transição para um ambiente novo costuma gerar, de início, uma queda no humor — a novidade em si já é um pouco aversiva — o que exige permanência sustentada e seleção cuidadosa das atividades, não desistência ao primeiro sinal de desconforto.

21 Escala de valores de vida e programação de atividades agradáveis

Uma escala de valores de vida, baseada na Terapia de Aceitação e Compromisso, avalia a importância atribuída a onze áreas da vida — como relações, trabalho e lazer — em comparação com as ações efetivamente realizadas no último mês, permitindo alinhar o comportamento do paciente aos próprios valores essenciais.

Uma lista adaptada de 320 atividades, organizada por frequência e prazer, serve de apoio à programação de atividades agradáveis — inclusive em casos de dissociação profunda, nos quais escolher qualquer ação viável já é um primeiro passo terapêutico.

22 Mindfulness e exposição emocional imaginada

Práticas de mindfulness — atenção aos sons, escaneamento corporal, o exercício do "céu e das nuvens" — são recursos aplicáveis diretamente em sessão, para direcionar a atenção a estímulos externos e promover regulação emocional sem julgamento.

A exposição emocional imaginada orienta o paciente a reviver cenas passadas, ou antecipar cenários futuros, com detalhe sensorial — treinando o controle de impulsos, a tolerância ao sofrimento e o desenvolvimento de respostas alternativas ao comportamento-alvo. O suporte a essa exposição começa pela respiração, segue com a nomeação da emoção e a observação da onda de impermanência, para afastar pensamentos catastróficos sobre o desfecho. A hierarquia de exposição avança da imaginação, para o treino em casa, para o roleplay em sessão diante de situações temidas, até a aplicação na vida real com um plano de solução já combinado.

23 Ação oposta

A ação oposta envolve nomear a emoção, avaliar se vale a pena regulá-la, checar os fatos, observar o próprio corpo e encontrar uma ação contrária ao impulso emocional. A postura corporal comunica ao cérebro se há perigo ou segurança — um mecanismo ilustrado, em aula, com estudos sobre cantores de ópera e sua postura em cena.

- **Medo** — a ação oposta é aproximar-se

- **Raiva** — a ação oposta é a gentileza
- **Tristeza** — a ação oposta é ativar-se
- **Vergonha** — a ação oposta é contar a alguém seguro
- **Culpa** — a ação oposta é seguir de cabeça erguida

24 Resolução de problemas e o mapa de decisão clínica

A resolução de problemas define a preocupação com precisão, avalia o quanto da responsabilidade cabe de fato ao paciente, gera uma lista de soluções com vantagens e desvantagens, e escolhe a menos pior como plano de ação. O adiamento da preocupação — debruçar-se sobre a lista de problemas por vinte minutos por dia, de preferência escrevendo — ajuda a conter a ruminação fora desse espaço reservado.

O mapa de decisão clínica orienta a escolha da intervenção perguntando duas coisas: a emoção se encaixa nos fatos da situação, e é efetivo agir de acordo com ela? As respostas direcionam para regulação emocional, reestruturação cognitiva, ação oposta, ou resolução da parte do problema que de fato cabe ao paciente resolver.

25 Referências

Danziger, S., Levav, J., & Avnaim-Pesso, L. (2011). Extraneous factors in judicial decisions. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 108*(17), 6889–6892.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion, 6*(3–4), 169–200.

Feldman Barrett, L. (2017). *How emotions are made: The secret life of the brain*. Houghton Mifflin Harcourt.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux. [ed. bras.: *Rápido e devagar: duas formas de pensar*. Trad. Cássio de Arantes Leite. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.]

Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2nd ed.). Guilford Press. [ed. bras.: *Treinamento de habilidades em DBT*, 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2026.]

Martí, L., Wu, S., Piantadosi, S. T., & Kidd, C. (2023). Latent diversity in human concepts. *Open Mind, 7*, 79–92.

McKay, M., Wood, J. C., & Brantley, J. (2007). *The dialectical behavior therapy skills workbook*. New Harbinger.

NOTA DE MÉTODO

Este resumo foi destilado a partir da transcrição automática da aula — repetições e marcas da fala oral foram removidas, o conteúdo foi reorganizado em ordem didática, e exemplos clínicos foram mantidos sem identificadores. O exercício do "pinguim" (seção 08) foi identificado e formalizado como Martí, Wu, Piantadosi & Kidd (2023), *Open Mind*. As referências de Ekman, Feldman Barrett, Kahneman, Linehan, Danziger et al. e McKay, Wood & Brantley foram formalizadas a partir de obras citadas em aula sem dados bibliográficos completos em fala; edições brasileiras conferidas junto às editoras (Companhia das Letras/Objetiva e Artmed) nesta revisão.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão. O arquivo guarda o que você preencher.

- [ ] Apliquei o exercício de emoção primária e secundária com um paciente, nomeando o julgamento do self crítico por trás da intensidade.
- [ ] Antes de trabalhar regulação emocional, checei se havia risco grave à vida pedindo tolerância ao mal-estar primeiro.
- [ ] Usei o mapa do afeto (valência x excitação) para situar onde um paciente está, em vez de só nomear "ele está mal".
- [ ] Apliquei o PLEASE com um paciente — e revisei sono, alimentação e exercício como parte do plano, não como aviso genérico.
- [ ] Nomeei, com um paciente, o valor de vida por trás de uma emoção intensa recorrente.

Minhas anotações — o que levo para a clínica

Para revisar — responda

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

01. **Um paciente diz que "não devia sentir raiva da mãe doente" — e por isso some de casa por dias. Como separar a emoção primária do julgamento que a transformou em emoção secundária?**

02. **Uma paciente borderline oscila várias vezes por dia entre euforia e desespero. Usando o mapa do afeto, o que priorizar primeiro no plano terapêutico?**

03. **Um paciente relata medo intenso de ser abandonado sempre que o parceiro demora a responder mensagem. Que valor de vida pode estar por trás desse medo, e como isso muda a condução do caso?**